Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 3 · Oktober 2026
S. 56–59 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

THEORETISCHER BEITRAG

Ethik und Regulierung künstlicher Intelligenz in der Psychotherapie

Autonomie, Verantwortung, Datenschutz und der Schutz vulnerabler Nutzerinnen und Nutzer im entstehenden europäischen Recht

Samuel R. Ashford, Sora Pazer und Eleanor M. Whitcombe
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Künstliche Intelligenz (KI) hält über Gesprächsagenten, klinische Entscheidungsunterstützung und automatisierte Dokumentation Einzug in die Psychotherapie. Diese Anwendungen werfen ethische Fragen auf, die in einem Feld, das auf Vertrauen, Vertraulichkeit und persönlicher Begegnung beruht, besonders dringlich sind. Dieser theoretische Beitrag untersucht fünf Problembereiche: die Achtung der Patientenautonomie und die informierte Einwilligung, die Zuschreibung von Verantwortung, wenn algorithmische Systeme an klinischen Entscheidungen mitwirken, den Schutz hochsensibler Gesundheitsdaten zusammen mit Transparenz und dem Risiko systematischer Verzerrungen, den Schutz vulnerabler Nutzerinnen und Nutzer in Krisensituationen sowie die regulatorische Antwort. Gestützt auf den Prinzipienansatz der biomedizinischen Ethik und die breitere Literatur zur Ethik von Algorithmen argumentieren wir, dass sich die ethische Bewertung von KI in der Psychotherapie nicht auf technische Leistungsfähigkeit reduzieren lässt. Wir skizzieren in allgemeiner Form, wie der europäische Rahmen aus Datenschutz-Grundverordnung, Medizinprodukteverordnung und KI-Verordnung diese Probleme adressiert und wo Lücken bleiben. Aus sinnzentrierter Perspektive betonen wir, dass Verantwortung, eine zentrale Kategorie der Logotherapie Frankls, nicht an eine Maschine delegiert werden kann. Abschließend formulieren wir Prinzipien für die verantwortliche Gestaltung, Evaluation und klinische Nutzung von KI in der Psychotherapie.

Schlüsselwörter: künstliche Intelligenz · Ethik der Psychotherapie · Verantwortung · Datenschutz · KI-Verordnung der EU

ABSTRACT

Artificial intelligence (AI) is entering psychotherapy through conversational agents, clinical decision-support tools, and automated documentation. These applications raise ethical questions of particular urgency in a field built on trust, confidentiality, and personal encounter. This theoretical contribution examines five areas of concern: respect for patient autonomy and informed consent, the attribution of responsibility when algorithmic systems contribute to clinical decisions, the protection of highly sensitive mental health data together with transparency and the risk of systematic bias, the protection of vulnerable users in crisis situations, and the regulatory response. Drawing on principlism in biomedical ethics and on the broader literature on the ethics of algorithms, we argue that the ethical evaluation of AI in psychotherapy cannot be reduced to technical performance. We outline in general terms how the European framework, consisting of the General Data Protection Regulation, the Medical Device Regulation, and the Artificial Intelligence Act, addresses these concerns and where gaps remain. From a meaning-centered perspective, we emphasize that responsibility, a central category of Frankl's logotherapy, cannot be delegated to a machine. We conclude with principles for the responsible design, evaluation, and clinical use of AI in psychotherapy.

Keywords: artificial intelligence · psychotherapy ethics · responsibility · data protection · EU AI Act

1 Einleitung

Psychotherapie hat sich stets auf Technologien irgendeiner Art gestützt, von der schriftlichen Fallakte bis zu Telefon und Videokonferenz. Die gegenwärtige Welle künstlicher Intelligenz (KI) unterscheidet sich jedoch in einer entscheidenden Hinsicht: Systeme auf der Grundlage maschinellen Lernens und großer Sprachmodelle übermitteln oder speichern

Kommunikation nicht mehr nur, sondern erzeugen Antworten, klassifizieren Äußerungen und erstellen Vorhersagen, die klinische Entscheidungen beeinflussen können (Torous et al., 2021). Jede dieser Funktionen berührt den Kern der therapeutischen Beziehung, die auf Vertrauen und Vertraulichkeit angewiesen ist.

Frühe Überblicksarbeiten des Feldes wiesen auf Fragen der Kompetenz, der Haftung, der Privatsphäre und einer möglichen Erosion menschlichen Kontakts hin (Fiske et al., 2019; Luxton, 2014). Der vorliegende Beitrag greift diese Fragen auf und ordnet sie fünf Bereichen zu: Autonomie, Verantwortung, Datenschutz und Transparenz, Schutz vulnerabler Nutzerinnen und Nutzer sowie Regulierung. Statt eine vollständige rechtliche Analyse vorzulegen, wollen wir die ethische Struktur der Probleme klären und aufzeigen, wie das europäische Recht auf sie antwortet. Dabei stützen wir uns durchgehend auf die sinnzentrierte Tradition, die persönliche Verantwortung ins Zentrum menschlicher Existenz stellt (Frankl, 1946/1985).

2 Autonomie und informierte Einwilligung

Die Achtung der Autonomie ist eines der vier Prinzipien, die Beauchamp und Childress (2019) neben Wohltun, Nichtschaden und Gerechtigkeit als Rahmen für die biomedizinische Ethik vorschlagen. In der Psychotherapie ist Autonomie sowohl das Recht von Patientinnen und Patienten, auf der Grundlage angemessener Information über ihre Behandlung zu entscheiden, als auch ein therapeutisches Ziel, da viele Formen der Psychotherapie darauf abzielen, Selbstbestimmung zu stärken.

Im Hinblick auf die informierte Einwilligung müssen Patientinnen und Patienten wissen, ob sie mit einem Menschen oder mit einer Software kommunizieren, was das System leisten kann und was nicht, wie ihre Daten verarbeitet werden und wer für das Angebot verantwortlich ist. Gesprächssysteme sind darauf ausgelegt, flüssige, scheinbar empathische Sprache zu erzeugen, was Nutzerinnen und Nutzer dazu verleiten kann, Verstehen und Fürsorge zuzuschreiben, wo lediglich statistische Textgenerierung am Werk ist (Bender et al., 2021). Eine unter solchen Fehlzuschreibungen erteilte Einwilligung ist ethisch brüchig, selbst wenn formale Anforderungen erfüllt sind.

Im Hinblick auf Autonomie als therapeutisches Ziel ist das Problem subtiler. Auf Nutzungsbindung optimierte Systeme können eher Abhängigkeit als Unabhängigkeit fördern, und persuasive Gestaltungsmerkmale können Nutzerinnen und Nutzer zu bestimmten Verhaltensweisen lenken, ohne dass diese ihnen reflektiert zugestimmt haben (Floridi et al., 2018). Eine Anwendung sollte daher nicht nur an kurzfristiger Symptomreduktion gemessen werden, sondern auch daran, ob sie das eigene Urteilsvermögen der Nutzenden unterstützt und, wo angezeigt, zur Inanspruchnahme menschlicher Hilfe ermutigt.

3 Verantwortung und Verantwortungslücke

Wenn eine Therapeutin oder ein Therapeut einen Fehler macht, greifen etablierte Strukturen beruflicher, rechtlicher und moralischer Rechenschaft. Ihr Verhalten ergibt sich aus Trainingsdaten, Gestaltungsentscheidungen und dem Nutzungskontext und ist oft selbst für die Entwickelnden nicht vollständig vorhersehbar. Matthias (2004) beschrieb die daraus entstehende Lage als Verantwortungslücke: Je autonomer ein lernendes System handelt, desto schwieriger wird es, seine Ergebnisse einer bestimmten Person zuzurechnen.

Für die Psychotherapie ist diese Lücke nicht bloß ein rechtliches Problem. Große Sprachmodelle können plausible, aber falsche Aussagen erzeugen, ein Phänomen, das breit unter dem Begriff der Halluzination diskutiert wird (Ji et al., 2023). Betrifft eine solche Aussage Medikation, Diagnose oder eine suizidale Krise, können die Folgen gravierend sein. Eine ethische Mindestanforderung besteht daher darin, klinisch relevante KI-Funktionen in eine klare Kette menschlicher Verantwortung einzubetten: der Hersteller für Gestaltung und Validierung, die Einrichtung für Auswahl und Überwachung des Werkzeugs und die behandelnde Fachperson für die im Einzelfall getroffenen Entscheidungen.

Aus logotherapeutischer Sicht ist Verantwortung nicht nur eine von außen auferlegte Pflicht, sondern ein konstitutives Merkmal menschlicher Existenz. Frankl (1946/1985) verstand Menschsein als Verantwortlichsein, das heißt als die Fähigkeit, auf die Anforderungen einer konkreten Situation zu antworten. Eine Maschine kann Ausgaben erzeugen, sie kann für diese aber nicht in diesem existenziellen Sinne einstehen. Dies stützt die verbreitete Position, dass KI das Urteil einer verantwortlichen Fachperson unterstützen, aber nicht ersetzen sollte, und es warnt davor, dass Fachpersonen algorithmischen Empfehlungen folgen, ohne sie zu prüfen.

4 Datenschutz, Transparenz und Gerechtigkeit

Daten zur psychischen Gesundheit gehören zu den sensibelsten personenbezogenen Informationen. Nach der Datenschutz-Grundverordnung zählen Gesundheitsdaten zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten, deren Verarbeitung untersagt ist, sofern nicht bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (Regulation (EU) 2016/679, 2016). Die ethischen Bedenken reichen gleichwohl über die Einhaltung des Rechts hinaus: Kommerzielle Anbieter können Anreize haben, Gesprächsdaten für die Produktentwicklung zu nutzen, und die Grenze zwischen Gesundheitsleistung und Konsumprodukt ist für Nutzerinnen und Nutzer oft unklar (Fiske et al., 2019).

Nutzerinnen und Nutzer sollten darüber informiert werden, wenn sie mit einem KI-System interagieren, und Fachpersonen sollten Grundlage, Grenzen und Validierungsstand der von ihnen eingesetzten Werkzeuge verstehen. Vollständige Erklärbarkeit komplexer Modelle mag unerreichbar sein, doch eine aussagekräftige Transparenz über Zweckbestimmung, Trainingsdaten, bekannte Fehlermuster und Evidenz ist erreichbar und ethisch geboten (Floridi et al., 2018; Mittelstadt et al., 2016).

Eng damit verbunden ist die Frage der Gerechtigkeit. Algorithmen, die mit Daten bestimmter Populationen trainiert wurden, können bei anderen schlechter abschneiden, und scheinbar neutrale Zielvariablen können strukturelle Ungleichheiten reproduzieren. Obermeyer et al. (2019) zeigten für einen weit verbreiteten Algorithmus im Versorgungsmanagement, dass die Verwendung von Gesundheitskosten als Stellvertreter für Versorgungsbedarf Schwarze Patientinnen und Patienten benachteiligte. Vergleichbare Risiken bestehen in der psychosozialen Versorgung, in der sich der Ausdruck seelischer Belastung zwischen kulturellen und sprachlichen Gruppen unterscheidet. Eine systematische Prüfung der Leistungsfähigkeit über Untergruppen hinweg sollte daher Teil jeder Evaluation sein.

5 Vulnerable Nutzerinnen und Nutzer und Krisensituationen

Menschen, die psychologische Hilfe suchen, insbesondere Minderjährige und Personen in akuten Krisen, befinden sich häufig in einem Zustand erhöhter Vulnerabilität. Eine vielzitierte Studie von Miner et al. (2016) ergab, dass weit verbreitete Gesprächsagenten auf Smartphones inkonsistent und oft unzureichend auf Äußerungen zu Suizidgedanken, Depression und interpersoneller Gewalt reagierten. Obwohl die untersuchten Systeme nicht als therapeutische Werkzeuge konzipiert waren, veranschaulicht die Studie ein allgemeines Problem: Nutzerinnen und Nutzer wenden sich in Krisenmomenten womöglich an verfügbare Technologie, unabhängig von deren Zweckbestimmung.

Ethisch bedeutet dies, dass Anbieter von Anwendungen für die psychische Gesundheit besondere Sorgfaltspflichten tragen. Dazu gehören die zuverlässige Erkennung von Krisensignalen, die klare Weiterleitung an menschliche Hilfe und Notdienste, der Schutz vor schädlichen Inhalten und Zurückhaltung bei Wirksamkeitsversprechen. Menschen, die ein existenzielles Vakuum im Sinne Frankls erleben, können für ein ständig verfügbares und bestätigendes Gegenüber besonders empfänglich sein. Ein System, das ausschließlich mit Bestätigung antwortet, mag Einsamkeit kurzfristig lindern, lässt die zugrunde liegende Sinnfrage jedoch unberührt.

6 Der europäische Regulierungsrahmen

In der Europäischen Union sind drei Rechtsinstrumente besonders relevant. Erstens regelt die Datenschutz-Grundverordnung die Verarbeitung von Gesundheitsdaten, einschließlich der Anforderungen an eine Rechtsgrundlage, Datenminimierung, Zweckbindung und die Rechte betroffener Personen (Regulation (EU) 2016/679, 2016). Zweitens gilt die Medizinprodukteverordnung für Software, deren vom Hersteller festgelegte Zweckbestimmung medizinische Zwecke wie Diagnose, Verhütung, Überwachung oder Behandlung von Krankheiten umfasst (Regulation (EU) 2017/745, 2017). Solche Software bedarf vor dem Inverkehrbringen einer Konformitätsbewertung entsprechend ihrer Risikoklasse.

Drittens führt die KI-Verordnung, die 2024 in Kraft trat und schrittweise Geltung erlangt, einen risikobasierten Rahmen für KI-Systeme ein (Regulation (EU) 2024/1689, 2024). Sie verbietet bestimmte Praktiken, darunter KI-Systeme, die manipulative Techniken einsetzen oder Schwächen aufgrund von Alter, Behinderung oder sozialer oder wirtschaftlicher Lage in einer Weise ausnutzen, die erheblichen Schaden verursacht. KI-Systeme, die selbst Medizinprodukte oder Sicherheitsbauteile solcher Produkte sind und einer Konformitätsbewertung durch Dritte unterliegen, gelten als hochriskant und müssen Anforderungen an Risikomanagement, Datenqualität, Dokumentation,

menschliche Aufsicht und Genauigkeit erfüllen. Zudem begründet die Verordnung Transparenzpflichten, etwa die, dass Menschen informiert werden müssen, wenn sie direkt mit einem KI-System interagieren, sofern dies nicht aus dem Kontext offensichtlich ist.

Gleichwohl bleiben wichtige Lücken. Viele Anwendungen für Wohlbefinden, Coaching oder Begleitung werden bewusst nicht für medizinische Zwecke vermarktet und fallen damit nicht unter das Medizinprodukterecht, obwohl sie von Menschen mit psychischen Problemen genutzt werden. Auch allgemeine Sprachmodelle werden zur Unterstützung eingesetzt, für die sie nicht konzipiert wurden. Die regulatorische Einordnung hängt daher wesentlich von der erklärten Zweckbestimmung ab, während die ethische Bewertung die tatsächliche Nutzung berücksichtigen muss. Berufsethik, klinische Leitlinien und unabhängige Evaluation bleiben unverzichtbare Ergänzungen des Rechts (Torous et al., 2021).

7 Fazit

Die ethischen Fragen, die KI in der Psychotherapie aufwirft, lassen sich nicht auf Genauigkeit oder Effizienz reduzieren. Sie betreffen die Bedingungen, unter denen Menschen einer helfenden Beziehung vertrauen, informierte Entscheidungen treffen und Urheberinnen und Urheber ihres eigenen Lebens bleiben können. Aus der Analyse folgen mehrere Prinzipien: Transparenz über die künstliche Natur und die Grenzen eines Systems; eine informierte Einwilligung, die das Risiko anthropomorphisierender Fehlzuschreibung ernst nimmt; eine klare Zuordnung menschlicher Verantwortung; strenger Schutz und sparsame Nutzung sensibler Daten; systematische Prüfung auf Verzerrungen; belastbare Krisenprotokolle; und unabhängige Evaluation vor einer breiten Verbreitung.

Regulierung kann einige dieser Prinzipien durchsetzen, sie kann aber die berufliche und persönliche Verantwortung derer, die solche Systeme entwickeln, empfehlen und nutzen, nicht ersetzen. Die sinnzentrierte Tradition erinnert daran, dass die entscheidende Frage nicht nur lautet, was Technologie kann, sondern wozu sie dient. KI in der Psychotherapie ist in dem Maße ethisch gerechtfertigt, in dem sie dem Menschen dient, seine Fähigkeit zu verantwortlicher Selbstbestimmung unterstützt und den Weg zu echter menschlicher Begegnung offenhält, statt ihn zu verschließen.

Literatur

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of biomedical ethics (8th ed.). Oxford University Press.

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 610–623). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

Fiske, A., Henningsen, P., & Buyx, A. (2019). Your robot therapist will see you now: Ethical implications of embodied artificial intelligence in psychiatry, psychology, and psychotherapy. Journal of Medical Internet Research, 21(5), e13216. https://doi.org/10.2196/13216

Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. Minds and Machines, 28(4), 689–707. https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5

Frankl, V. E. (1985). Man's search for meaning (Rev. and updated ed.). Washington Square Press. (Original work published 1946)

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys, 55(12), Article 248. https://doi.org/10.1145/3571730

Luxton, D. D. (2014). Artificial intelligence in psychological practice: Current and future applications and implications. Professional Psychology: Research and Practice, 45(5), 332–339. https://doi.org/10.1037/a0034559

Matthias, A. (2004). The responsibility gap: Ascribing responsibility for the actions of learning automata. Ethics and Information Technology, 6(3), 175–183. https://doi.org/10.1007/s10676-004-3422-1

Miner, A. S., Milstein, A., Schueller, S., Hegde, R., Mangurian, C., & Linos, E. (2016). Smartphone-based conversational agents and responses to questions about mental health, interpersonal violence, and physical health. JAMA Internal Medicine, 176(5), 619–625. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.0400

Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society, 3(2). https://doi.org/10.1177/2053951716679679

Obermeyer, Z., Powers, B., Vogeli, C., & Mullainathan, S. (2019). Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. Science, 366(6464), 447–453. https://doi.org/10.1126/science.aax2342

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). (2016). Official Journal of the European Union, L 119, 1–88.

Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices. (2017). Official Journal of the European Union, L 117, 1–175.

Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). (2024). Official Journal of the European Union, L, 2024/1689.

Torous, J., Bucci, S., Bell, I. H., Kessing, L. V., Faurholt-Jepsen, M., Whelan, P., Carvalho, A. F., Keshavan, M., Linardon, J., & Firth, J. (2021). The growing field of digital psychiatry: Current evidence and the future of apps, social media, chatbots, and virtual reality. World Psychiatry, 20(3), 318–335. https://doi.org/10.1002/wps.20883

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Ashford, S. R., Pazer, S., & Whitcombe, E. M. (2026). Ethics and Regulation of Artificial Intelligence in Psychotherapy: Autonomy, responsibility, privacy, and the protection of vulnerable users under emerging European law. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(3), 56–59.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.